

Toxicologie des IRS, IRSN, IMAO et autres antidépresseurs

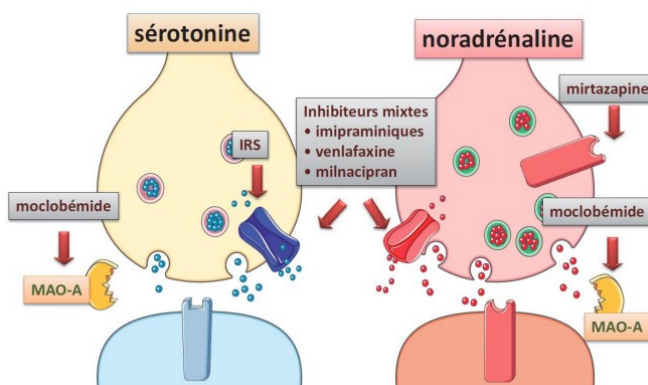
Antidépresseurs

- Physiopathologie de la dépression :
 - ↓ 5-HT
 - ↓ NA
 - ↓ DOPA
 - ↓ Plasticité neuronale
- Certains antidépresseurs aussi prescrits pour les troubles anxieux
- Plusieurs classes médicamenteuses :
 - antidépresseurs imipraminiques = tricycliques (AD historique de référence)
 - IMAO-A (peu utilisé)
 - IRS (+ utilisé)
 - IRSN (+ utilisé)
 - autres antidépresseurs
- Fréquence élevée d'intoxications :
 - **Levée d'inhibition** favorisant le geste suicidaire
 - Pouvoir toxique
 - **Marge thérapeutique étroite**

Mécanisme d'action

Pour traiter un épisode dépressif, l'approche pharmacologique repose essentiellement sur l'augmentation des transmission sérotoninergique et noradrénergique.

La stimulation de leur transmission a lieu au niveau **pré-synaptique** en bloquant les systèmes de recapture respectifs (IRS, IRSN et inhibiteurs mixtes).



Moclobémide : empêche la dégradation de la sérotonine et de la noradrénaline en métabolites inactifs en bloquant la MAO-A.

Mirtazapine : (autres AD) blocage des récepteurs pré-synaptiques noradrénergiques

Cinétique

FAMILLE	DCI	Biodis-ponibilité	Pic plasmatique	Premier passage hépatique	Métabolites actifs	Élimination rénale	1/2 vie élimination (h)
IRS	Citalopram	80%	2 à 4 h	non	oui	15%	33
	Escitalopram	80%	4 h	non	oui	majoritaire	30
	Fluoxétine		6 à 8 h	oui	oui	60%	4 à 6 j
	Fluvoxamine	53%	3 à 8 h	oui	non	90%	17-22
	Paroxétine		2 à 8 h	oui	non	70%	24
	Sertraline		5 à 8 h	oui	non	50%	26
IRSN	Milnacipran	85%	2 h	non	non	90%	8
	Venlafaxine LP		6 h	oui	oui	95%	15
	Duloxétine	32-80%	6 à 10 h	oui	non	oui	8-17
IMAO	Moclobémide	80%	1 h	oui	oui	95%	2-4
« Autres antidépresseurs »	Miansérine	30%	2-3 h	non	non	70%	17
	Mirtazapine	50%	2 h	non	oui	oui	20 à 40

À l'exception du **milnacipran**, **vinlafaxine** et du **moclobémide**, les AD sont en général des **molécules lipophiles** qui ont un **volume de distribution élevé**. Cette importante distribution dans l'organisme limite l'intérêt de l'épuration extra-rénale.

Élimination :

- les **IRS** ont une élimination mixtes : **biliaire** et **rénale** (Hormis la **Fluvoxamine** (éliminée quasi-exclusivement par le rein))
- l'élimination des AD qui subissent un cycle entéro-hépatique et/ou qui présentent des métabolites actifs est relativement lente, ex : **fluoxétine**
- **moclobémide** et **IRSN** : demi-vie plus courte que les autres classes et élimination surtout **rénale**

Toxidrome

L'intoxication par des AD peut avoir plusieurs expressions :

- **Syndrome anticholinergique** : mydriase bilatérale, bouche sèche, rétention d'urine et constipation, tachycardie sinusale
- **Troubles neurologiques** : état d'agitation jusqu'au coma (peu profond, de courte durée et hypertonique), convulsions, myoclonies, syndrome pyramidal
- **Troubles respiratoires** : dépression respiratoire
- **Troubles cardiovasculaires** : troubles du rythme ou de conduction
- En cas d'association, possible **syndrome sérotoninergique** :
 - Symptômes **psychiques** (agitation, confusion, convulsion)
 - Symptômes **moteurs** (tremblements, myoclonies, rigidité)
 - Symptômes **végétatifs** (mydriase, hyperthermie, sueurs, frissons, tachycardie ou tachypnée)
 - **Mortalité 10 %**

Les syndromes varient d'une classe à l'autre :

- avec les **IRS** peu d'effet anticholinergique, de toxicité cardiovasculaire mais risque de dépression respiratoire en cas d'intoxication
- avec les **IRSN** : altérations de la conscience, convulsions, troubles digestifs
- avec les **IMAO** : troubles du SNC et troubles cardiovasculaires
- **mirtazapine** : symptômes peu spécifiques (somnolence, tachycardie, nausée, vomissements)
- **miansérine** : syndrome anticholinergique et troubles de la conduction intra-cardiaque

Prise en charge de l'intoxication

- Arrêt du traitement causal
- **Hospitalisation**
- **Charbon activé** : si < 2h = décontamination digestive (possible quelque soit l'AD)
- **Symptomatique** :
 - Coma = intubation + ventilation assistée
 - Convulsions = **diazépam** (10 à 20 mg) ou **clonazépam** (1 mg) IV
 - Trismus invalidant = curarisation
- Réhydratation
- **Surveillance** : ECG
- Faible intérêt de l'analyse toxicologique (peu de corrélation concentration-symptômes)

Ce qu'il faut retenir

- Poly-intoxication massive à but suicidaire
- Généralement **peu symptomatiques** (même pour des doses importantes)
- Evolution favorable en 24h
- En cas d'association : **syndrome 5-HT** = complication redoutée et potentiellement mortelle
- Prise en charge : +/- Charbon activé et Symptomatique en hospitalisation